

データ分析で挑戦！ 「長崎県民の手取りを増やす」 健康プロジェクト

協会けんぽ長崎支部の
「保険料率」を下げるには、どうすればいいか？

長崎データ塾2026/9/28

高見 吉忠、加藤 空武、黒崎 滉一郎、小場 康剛、直江 孝之、森下 享、辻本 航

協会けんぽ長崎支部の保険料率について



【構造】 特定健診受診率 全国ワースト2位

病気が重症化しやすく、医療費が高止まりする構造的欠陥。



【結果】 保険料率 10.45%

全国ワースト4位という極めて厳しい現実。



精神論（健康になろう）



圧倒的な経済的メリット
（保険料が安くなる＝手取りが増える）

「手取りが増える」
という動機でしか、
人は動かない。

見過ごされている「お金」の現実

長崎県（ワースト4位）

10.45%

年収400万円で
【約209,000円】

新潟県（全国最低水準）

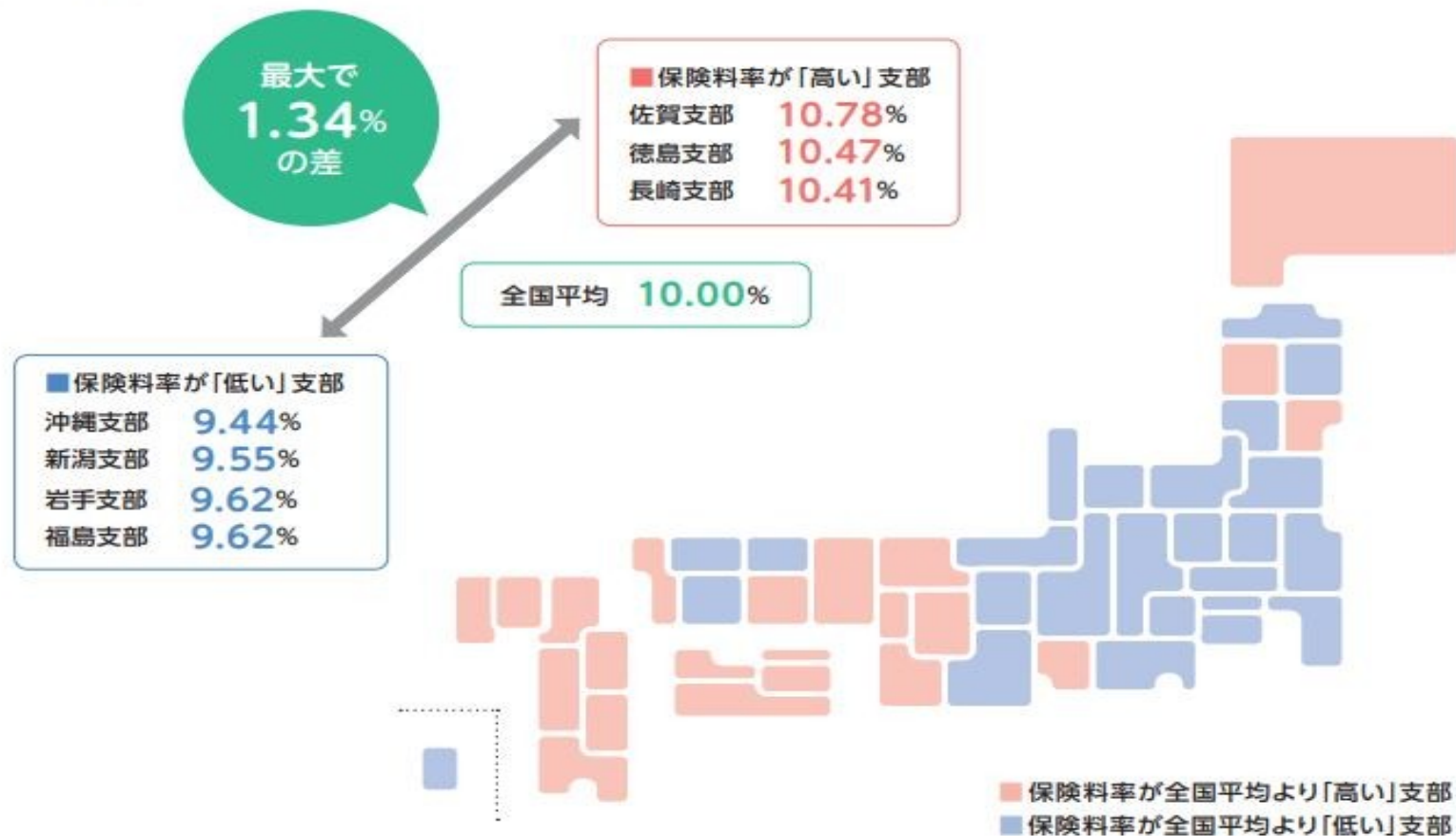
9.35%

年収400万円で
【約187,000円】

差額：約1.1%
＝

【年間 約44,000円】
の負担増！

● 2025年度の都道府県支部ごとの保険料率



九州が抱える構造的なハンディ



全国ワースト5のうち、4県が九州に集中しています（佐賀、福岡、熊本、長崎、鹿児島）。

このままでは、九州・長崎の企業は「高い固定費（社会保険料）」によって、全国での経済的競争力を失っていくリスクがあります。

もし保険料率を全国最低レベルにできれば、長崎経済に何が起きるか？

保険料率の引き下げは、単なるコスト削減ではありません。

県外へ流出していた資金を県内に留め、地域経済を活性化させる起爆剤となります。

約170億円

もし0.1%下がれば？



現在の保険料率を新潟県レベル（約1.1%差）まで改善できた場合、**年間約170億円が県内に留まる**計算になります。

「100億円規模のお金を、医療費から『県民の給与』と『企業の利益』に取り戻すことになります。」

年間「170億円」について



Check

インセンティブ制度

協会けんぽには、加入者・事業主の皆さまの取組を保険料率に反映させるインセンティブ制度があります。この制度は、5つの指標に基づき、支部をランク付けし、上位の支部は保険料率が引き下げられる制度です。

すべての加入者・事業主の皆さまの健康への取組が医療費適正化につながります。

協会けんぽも皆さまの取組を全力でサポートさせていただきますので、一緒に取り組んでいきましょう。



●5つの指標

1

特定健診等の
実施率

2

特定保健指導の
実施率

3

特定保健指導
対象者の
減少率

4

医療機関への受診動奨基準に
おいて速やかに受診を要する者
の医療機関受診率

5

ジェネリック
医薬品の
使用割合

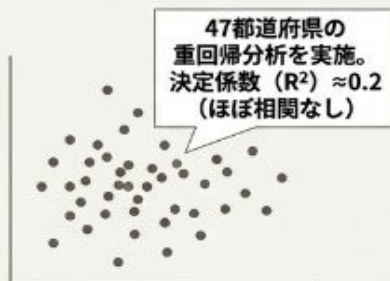
データ分析開始と、確認作業、軌道修正

初期仮説



協会けんぽの
『インセンティブ5指標』を
頑張って点数を稼げば、
保険料率は下がるはずだ

データ検証と挫折



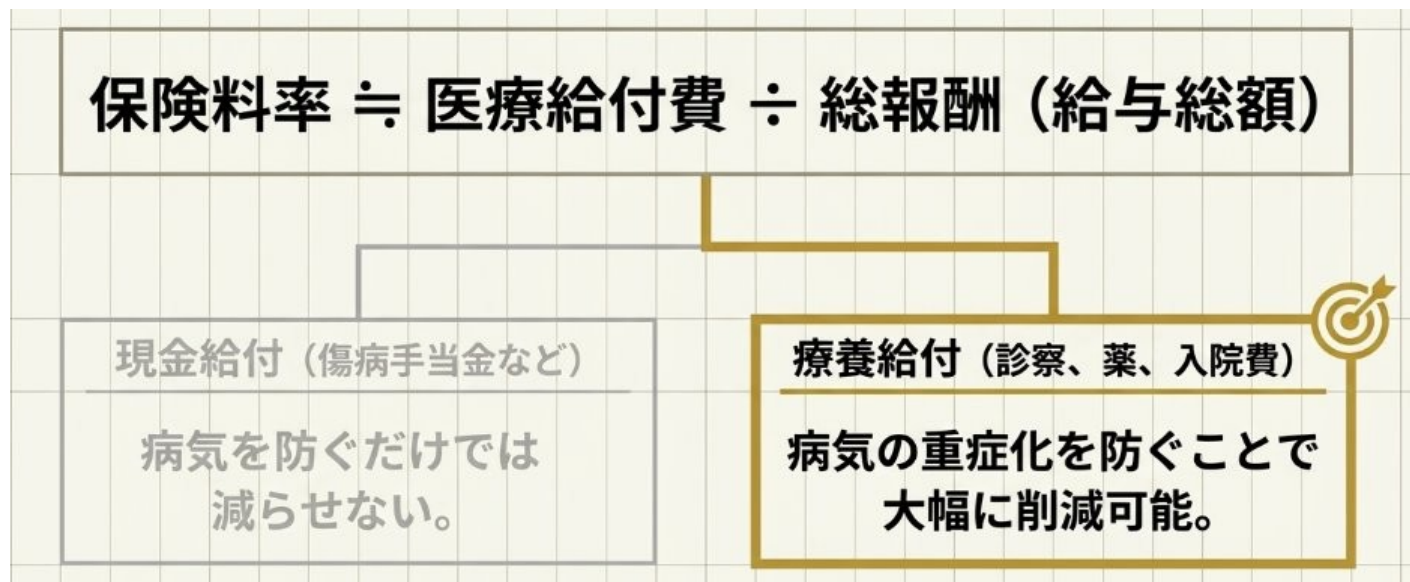
47都道府県の重回帰分析
重断分析を実施。
決定係数 (R^2) ≈ 0.2
(ほぼ相関なし)

突きつけられた現実



インセンティブの点数稼ぎ
インセンティブの点数稼ぎ
だけでは保険料率は変わら
ない（最大±0.46%の調整
項に過ぎない）。
本質は「医療費そのもの」
を減らすことにある。

真の「阻害要因」はどこにあるのか？



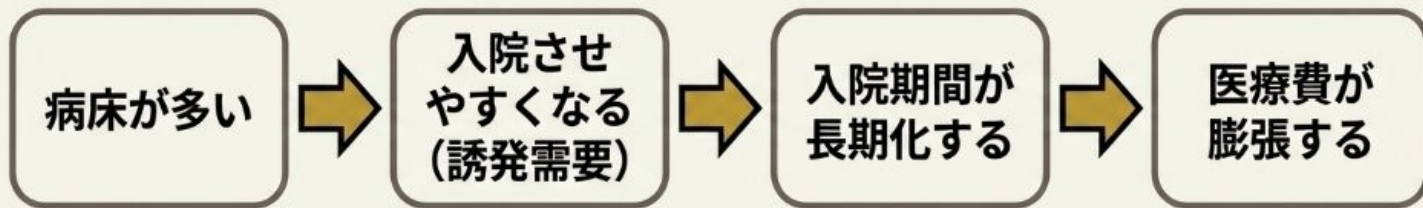
インセンティブの点数ではなく、「療養給付費（医療費そのもの）」を減らさなければ、長崎の保険料率は下らない。

地域特性という巨大な壁（病床数との相関）

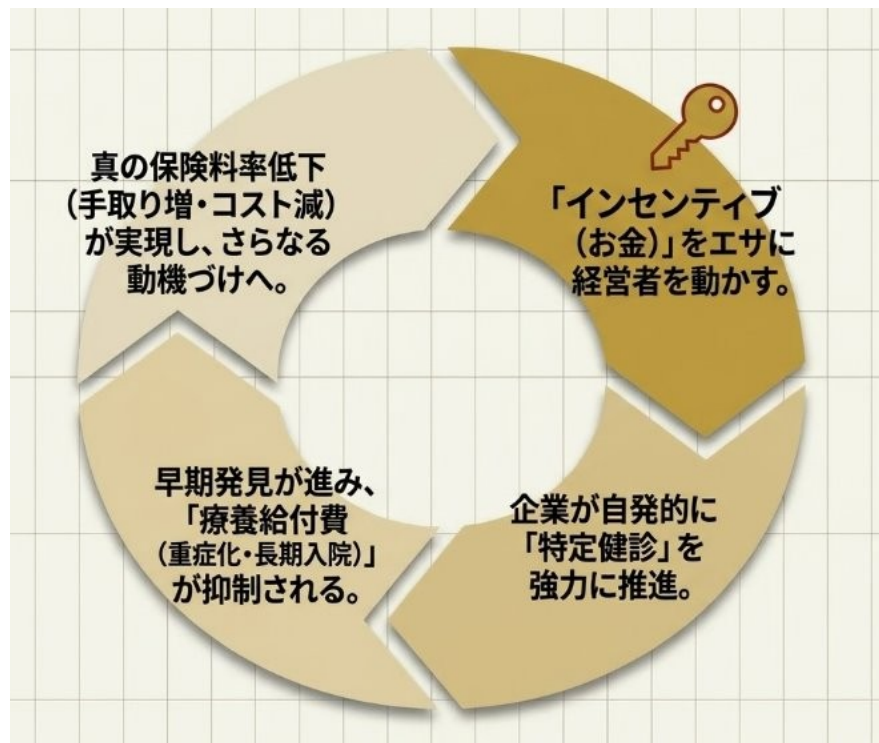
地域特性という巨大な壁：医療費を押し上げる「病床数」の真実



相関係数 $r \approx 0.4 \sim 0.5$ 。
長崎県は全国平均を
大きく上回る病床数。



アプローチ



「医療費(療養給付費)を下げよう」「入院期間を短くしよう」と経営者に言っても、ピンときません。

だからこそ、「インセンティブ(お金)」を入り口にします。

戦略：経営者には「インセンティブで保険料が下がる(手取りが増える)」という分かりやすいエサ(シミュレーター)を提供する。それに乗って企業が「健診」を推進すれば、結果として早期発見が進み、「療養給付費(重症化・長期入院)」が減り、真の保険料率低下に繋がる仕組みです。

アプローチについて

	従来のアプローチ	ケンポー団のデータドリブン・アプローチ
ターゲット	全員に一律で呼びかけ	データで効果の高い層を特定し ターゲットを絞る
メッセージ	「健康のため」という 精神論	「手取り増・コスト減」という 経済的メリットの可視化
手段	ポスター・チラシでの 一斉周知	シミュレーターで 個別企業の削減額を提示
効果測定	測定が難しく、 PDCAが回らない	投資対効果（ROI）が明確で 効果検証が可能
行動エンジン	「やるべきだから」という 義務感	「やれば得をする」という 納得感

成果物① 保険料削減シミュレーター

機能

協会けんぽの
インセンティブ5指
標を入力。

翌年度の保険料率と
削減額（会社負担・
従業員手取り別）を
瞬時に予測表示。



提供価値

最強の営業ツール：
「長崎が全国トップ
レベルになったら、
自社の利益はいくら
増えるか？」を
直感的に見せ、
経営者の重い腰を
上げさせる。

成果物② 分析レポート(何が効かないか)

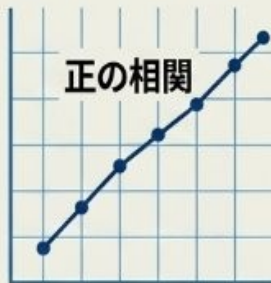
分析項目	結果	示唆
インセンティブ5指標 vs 保険料率	決定係数 $R^2 \approx 0.2$ (ほぼ相関なし)	指標の点数稼ぎだけでは大きく変わらない
保険料率の構成要素	療養給付+共通料率で約9割	本質は「医療給付費÷総報酬」
病床数 vs 医療給付費	相関係数 $r \approx 0.4 \sim 0.5$	長崎は平均以上、構造的要因

「私たちは『何が直接効かないか』をデータで確認。これは『何が本当に効くか』を探すため。」

成果物③ 分析レポート(何が効くのか)



①負の相関:
特定健診受診率が10%高いと、
保険料率が約0.11%低い
($p < 0.001$)。



②正の相関:GAM解析によ
り、受診率が10%向上すると、
県民一人あたりの生産性が
【約20万円】高くなることが
示唆された。

【経営者へのメッセージ】

「社長、健診で社員を半日休ませるのは『コスト』ではありません。健診は、医療費を下げて社会保険料負担を減らすだけでなく、社員の生産性を一人あたり20万円押し上げる、最も利回りの良い『投資』なのです。」

今後の展望(第2期へ)

今回のプロジェクト(第1期)で得られた知見を基に、次のステップへ進みます。

①「療養給付費」削減の因子分析(第2期の核心テーマ): 病床数だけでなく、地域の食習慣、運動習慣など「何を頑張れば最も効率的に下がるか」の特定。

② 企業向け「健康投資」パッケージの作成: シミュレーターを核とした啓発資料の拡充。

③ 協会けんぽ・行政との連携強化: 分析結果を基に政策提言を行い、「長崎モデル」として全国展開できるエビデンスを構築する。

まとめ

**健康は「コスト」ではなく、
未来の資産を創る「投資」です。**

長崎県が「健康」という切り口で経済を成長させることは、可能なことがわかりました。

単なる給付改善ではなく、県民の手取りを増やし地域経済の好循環を生み出す一つです。

データを、長崎の未来を変えるアクションに繋げていければと思います。